臺灣心理健康聯盟新聞稿

【發稿日期】2026 年 10 月 2 日（當日會後發稿）

沒有心理健康就沒有健康臺灣！
立院厚生會與臺灣心理健康聯盟 77 個民團
8 立委力挺跨黨派促《精神衛生法》心理健康促進落地
發布「心理健康城市共同宣言」

響應 2026 世界心理健康日
「心理健康城市網絡論壇：從健康邁向幸福」

主辦單位：中華心理衛生協會暨臺灣心理健康聯盟

合辦單位：立法院厚生會 × 財團法人厚生基金會、陳菁徽立法委員、林月琴立法委員、王正旭立法委員、邱慧洳立法委員、廖偉翔立法委員、李彥秀立法委員

致詞代表與發言人：臺灣心理健康聯盟張珏召集人、 中華心理衛生協會林綺雲理事長、 衛生福利部呂建德政務次長、 陳菁徽立委（國）兼厚生會會長、王正旭委員（民）、邱慧洳委員（眾）、林月琴委員（民）、劉書彬委員（眾）、李彥秀委員（國）、廖偉翔委員（國，丁旗源主任代表）、王育敏委員（國，繆鑫法案助理代表）、衛生福利部心理健康司陳柏熹司長、衛生福利部國民健康署蔡維誼主任秘書、衛生福利部中央健康保險署陳亮妤署長、衛生福利部社會及家庭署家庭支持組簡杏蓉組長、國家衛生研究院陳為堅副院長、臺北市政府衛生局黃建華局長、臺南市政府社會局 郭乃文局長、雲林縣政府氣候變遷辦公室林世媚執行長、社團法人臺灣照顧管理協會張淑慧榮譽理事長、國教行動聯盟王瀚陽理事長、世界心理衛生聯盟李思賢理事、中華心理衛生協會丘彥南常務理事

「傾聽真實聲音，推動實質改變；沒有心理健康，就沒有健康臺灣！」

今日（10 月 2 日）在立法院群賢樓，中華心理衛生協會召集臺灣心理健康聯盟（77 個單位），民間團體與國會代表（8 席）、衛生部門 5 首長與縣市代表齊聚響應 2026 世界心理健康日，發布**心理健康城市共同宣言：**

2026 世界心理健康日，我們攜手政府與民間、中央與地方，

落實修法精神，將心理健康促進化為在地行動，

傾聽生命經驗、消除社會污名，

從健康邁向幸福，共創社會韌性與全民幸福的心理健康城市！

世界心理健康聯盟（WFMH）訂定 2026 世界心理健康日全球主題為「傾聽在地生命經驗：真實聲音，實質改變（Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change）」，呼應世界衛生組織（WHO）推動之「社區化與去機構化」趨勢。

心理健康是社會韌性與個人幸福的基石。推動「健康臺灣」國政願景，必須融入心理健康促進！

適逢精神衛生法施行細則增訂第 2 條，明訂「心理健康促進」的定義為「依政策及法令，由政府及民間投入資源，提升個人、家庭、學校、社區、職場及社會環境保護心理健康因子，減少不利心理健康之風險，維護及增進人民心理健康之措施」。我國法律展開了「心理健康促進」一個跨時代的定義：它是一項由政府與民間共同投入，涵蓋個人、家庭、學校、社區、職場到社會環境的全面性保護、預防與促進的措施。

心理健康融入所有政策（Mental Health in All Policies, MHiAP），以逐步普及全民心理健康

《精神衛生法》明定「中央主管機關」衛生福利部與 9 個核心部會（教育、勞動、內政、法務、國防、財政、金融、文化、通訊等）；行政院於核定「全民心理健康韌性計畫（114-119 年）」，由衛生福利部結合教育部、勞動部、內政部、法務部、國防部、經濟部、交通部、文化部等共 13 個部會共同推動，擴大了《精神衛生法》原有的部會格局，更前瞻性地將法條未點名但實務上具備高度基層心理需求的原民會、農業部、退輔會、行政院人事總處一併納入，將「心理健康融入所有政策」列為核心推動原則，全面提升國人心理健康福祉，以逐步達成「健康臺灣」國政願景。

國會倡議：跨黨派立委捍衛兒青與醫護職場權益

本次論壇獲得國會重視，表達對修法後主管機關和各部會能將心理健康促進落實於施政的期待。現任立法院厚生會會長陳菁徽委員廣邀本會期衛環委員、具醫藥公衛背景委員，關注兒青心智健康及全民心理健康議題的委員廣為參與。陳委員以全球心理健康憂鬱、焦慮等問題普遍，尋求協助的比例卻不到 25%。厚生會也特別關注台灣兒少心理問題嚴峻，自殺率、精神疾病終身盛行率皆高，近期成立「兒青心智健康委員會」，積極推動法制改革、早期預防與跨部會協作，建立完善的兒少心理健康防護網。王正旭委員，厚生會副會長亦從臨床醫學實證補強，指出癌症病友確診後有高達三成以上需要使用精神藥物，足見心理健康在疾病醫療中的龐大需求。委員們紛紛從兒青少早期介入、教師基層支持與醫護高壓職場環境等長期關注的議題和對象，提出多項具體且具前瞻性的施政建言。

立法委員林月琴，也是厚生基金會兒少權益委員會召集人指出，世界衛生組織（WHO）表示，全球已有超過 10 億人面臨心理健康問題，心理健康是當前最迫切的公共衛生挑戰之一。林月琴認為近年台灣兒少自殺率與通報人次的上升，顯示兒少心理健康亟需重視，關鍵在於檢視制度是否遺漏了有需要的孩子。她觀察到，現在越來越多孩子願意主動求助，但大人對心理疾病的誤解與汙名，往往讓孩子在求助時受到阻礙，難以及時獲得協助。

立法委員林月琴表示，她支持賴總統在健康台灣推動委員會中強調的，要由政府帶頭強化全民心理健康韌性。本會期她將與兒少代表一起合作，共同討論行政院「全民心理健康韌性計畫」六大策略中的「推展全方位心理健康促進」，檢視未成年人可使用的服務資源，並推動提升民眾心理健康識能，讓每個孩子都能被好好接住。

具備護理與法律雙專業背景的邱慧洳委員強調，擁有健康的心理，才能培育出健全的個人，進而在求學、就業與社會各層面充分發揮潛能、貢獻所長。面對當前青壯世代憂鬱與焦慮盛行率持續攀升的現況，政府必須提出更強有力的早期介入機制。邱慧洳指出，現行行政院「全民心理健康韌性計畫」雖已將免費心理諮商支持服務年齡下修至 15 歲，但仍有美中不足之處，她全力倡議應將適用年齡進一步下修至國中階段（12 至 14 歲青少年），因為國中生在步入青春期時所面臨的心智適應與心理需求，遠超過成年人的想像。此外，針對長期處於過勞、高壓且須輪值三班的護理人員，邱慧洳也為醫護勞權請命，要求政府除了現行補助的 3 次免費諮商外，應針對護理人員及高壓職場勞工加碼提高補助諮商次數。她同時具體建議，衛生福利部目前正在推動的「護理友善職場認證典範」與獎勵金制度，應實質將「提供員工心理諮商支持措施」納入友善職場的評核指標，從制度面落實對

醫護身心健康的實質保障。

本身長期在大學任教的**劉書彬委員**深感基層教師的辛勞。她指出，現代教師的角色早已不只是單純的知識傳遞者，更是學生生命經驗的陪伴者與校園文化的形塑者；因此，唯有「老師心理健康」，學生的受教權益與校園安全才能獲得根本保障，進而提供孩子健康成長的沃土。劉書彬觀察到，現今基層教師面臨龐大的行政庶務壓力與繁重的教學負荷，政府首要任務應是落實行政減量，並為教師社群提供專業的心理輔導、預防性支持與跨網絡資源整合。透過建構完善的教師心理支持支持系統，才能讓老師安心教學、學生快樂學習，進而讓家庭走向幸福，實質推進校園「親師生」全體從健康邁向幸福。

李彥秀委員觀察現代民眾無論在職場、家庭、親職溝通、同儕互動或社交關係中，都承受著極大的精神壓力，這也是近期立法院社會福利及衛生環境委員會（衛環委員會）及朝野立委高度凝聚共識、齊心關注心理健康的原因。李彥秀鄭重承諾，立法院將持續努力，作為教師與學生心理健康的堅實後盾，確保社會安全網能真正接住每一個人。李彥秀特別舉出台北市與民間團體合作成立的「向日葵學園」（中輟學生輔導與精神復健嘗試機構）為成功範例，該學園透過結合醫療、心理與特教的跨專業團隊，實質協助因心理或精神困擾中斷學業的孩子重建心理韌性、順利重返校園。呼籲中央與地方政府應和團體合作，持續挹注並支持創新的社區整合型服務，公私協力落實全民心理健康促進。

政策落實：衛福四司署的作為

今年的論壇作為心理健康融入各項政策的首發行動，從衛生部門，如何

將心理健康融入健康政策開始，逐年盤點、深化。

衛福部心健司陳柏熹司長表示心理健康不只是衛生機關的業務，而是所有公共政策的共同責任；政府必須在所有政策的制定與評估中，系統性考量對人民心理健康的影響。心健司主導落實全民心理健康韌性計畫，除了去汙名化與資源布建，更將致力於加強投資心理健康，完善全方位的連續性照護，從傳統的疾病治療全面轉向促進與預防並重。心理健康融入各項政策不是口號，而是全球共識與臺灣確立的政策方向。

健保署陳亮妤署長表示健保署的核心任務是透過精準的資源配置，實質提升身心健康服務的可近性，讓有需求的民眾能更及時、更方便地獲得專業協助。加強早期心理健康投資與介入，不僅能有效接住身心脆弱的個案，更能從源頭防範疾病惡化，進而降低後續龐大的醫療與社會成本。「我們將持續優化健保給付與支持系統，與心理健康司及臨床醫學界無縫對接，為全民構築最堅實的身心健康防護網。」

國健署則積極將心理健康促進深度融入現行的各項非傳染性疾病防治與健康促進政策中。從高齡友善、婦幼健康到社區營造，身體健康與心理韌性不可分割，我們必須為全民打造一個能減少社會排除、促進參與的支持性環境。**國民健康署主任秘書蔡維誼**表示「我們將落實全生命週期的健康照護，透過跨機關的資訊與服務對接，讓民眾在日常生活中就能自然提升心理健康識能。」

社家署推動「心理健康融入社會及家庭支持服務」的實務經驗，讓脆弱家庭在面對經濟與照顧壓力時，能同步獲得心理韌性的支撐。**社家署家庭支持組組長簡杏蓉表示**，一線的社福中心是家庭的守門人，我們在強化社

會安全網的架構下，致力將心理健康促進與初級預防，直接送進社區與家庭的核心。家庭支持與心理衛生必須深度公私協力，我們將與民間團體及跨部會緊密合作，避免任何一個面臨多重危機的家庭被漏接。

根據精神衛生法第 4 條，**衛生福利部依法每四年必須公布一次「國家心理衛生報告」**，期待國衛院作為國家級醫療衛生智庫，能將衛福部各署司的數據（婦幼孕產全生命週期及癌友家庭、慢性病患之心理支持需求與社區支持網絡的覆蓋率、健保大數據及財務分析、危機家庭心理健康風險的社會決定因素、家內/家外照顧者支持覆蓋率等）進行流行病學與實證醫學研究，提供具備國際視野、在地化文化敏感度的跨部會行動指引與實證支持。

國衛院副院長陳為堅現場提出跨部會實證資料回應，美國研究證實針對糖尿病、心血管疾病和憂鬱症的共病患者，從研究發現共同的風險因子、有利的介入因子，採取「跨科別整合性照顧」的療效與風險因子控制，遠比個別跨科就醫更具實質效益。他鼓勵本土醫學界積極開發包含心理健康的共同照護模式，打破目前糖尿病照護面臨末期洗腎等疾病瓶頸。此外，國衛院最新調查研究發現，11 至 19 歲兒少在過去一年有 2.5% 曾傳送私密性相關訊息，進而引發自傷、被恐嚇與網路霸凌，亟需立法部門管制措施。陳為堅現場宣布，國衛院已正式規劃並啟動「116 年全國心理健康調查」之先期試辦階段，未來將定期進行，為國家建構精準的兒少心理發展調查指數。

地方實踐：台北、台南、雲林三大幸福城市治理

打造一座心理健康城市，需要公私協力締結網絡。為從法規、中央政策到地方實踐心理健康促進，本次論壇特邀請地方縣市分享心理健康融入城市治理的實際案例，府內跨局處合作與社會資源連結，本次由臺北市政府衛生

局、臺南市政府社會局及雲林縣政府氣候變遷辦公室分享地方的亮點。

臺北市由市長親自領軍，透過「心理健康暨自殺防治委員會」橫向**整合府內 10 大局處**，將心理健康從單點的醫療診斷拉高為城市治理的全面市民支持。**臺北市政府衛生局黃建華局長**分享為徹底打破傳統局處本位，臺北市率先出招**將心理健康促進納入跨局處年度 KPI 共同評價指標，用制度建立跨部會共同投資與問責的行政誘因**。市府未來將以全生命週期為視野，透過數位單一入口全面串接社政、衛政、教育與就業資源，打造更有溫度的幸福韌性城市。

臺南在賑災基金會支持下，橫向整合社會局與三大心理職能公會，建立全國示範的**「災後復原暨社會處方箋支持體系」**。透過於 17 個重災區全面布建的**50 站社區防災韌性關懷站與 17 點互動歇腳點**，落實「先普查、再篩選、後介入」的三階段分層服務，開立具體可行的「社會處方」，實質協助超過 120 戶家庭重建身心韌性與社會依附。**臺南市政府社會局郭乃文局長**從臨床心理與大腦科學觀點破題，強調面對高齡失能、孤寂感與 AI 依賴等新型態心理災難，必須將心理健康視為主流價值，打破疾病討論的汙名化。

雲林縣以「北漂不再是唯一」為核心，**雲林縣政府因應氣候變遷專案辦公室林世媚執行長**將幸福治理公式定義為工作、人才、家庭與健康的加總，致力打破傳統農業縣的高齡與青年外移限制。雲林利用 AI 技術推動智慧農業風險分析，並首創**「醫消聯防虛實整合系統」與「智慧繁星 E 療」偏鄉遠距會診**，成功將救災存活率從 7% 大幅提升至 23%。縣府更推動「全齡幸福支持體系」，透過**「萬寶龍計畫」催生**讓出生率躍升全國第一，並布建**全國首創的 221 處長青食堂**解決高齡農村的孤獨與資源落差，讓雲林成為亞洲唯

一兩度入選 ICF 全球 Top 7 的智慧城市，實質落實心理健康融入永續城鄉的終極目標。

民團呼籲：聆聽活的生命經驗 終止日常隱形歧視

在民間團體與專業學者回應環節，**社團法人臺灣照顧管理協會張淑慧榮譽理事長**回應衛福部各司署到地方跨局處治理的工作都需要縱向行政授權與橫向資源連結，共同保障並促進不利群體的心理健康人權。她以「讓每一個人都被接住：推動不利處境族群心理健康融入所有政策」為題發表關鍵評論，直言：「壓力、資源缺乏與求助門檻的疊加，絕非多開一間諮商室就能解決。」呼籲臺灣必須徹底告別「等落水才撈救」的下游醫療思維。張淑慧理事長引述國際實證指出，後端醫療與危機處理僅能決定 20% 的心理健康，其餘 80% 的心理韌性，完全取決於居住、收入、教育、照顧負擔與歧視經驗等「社會環境因子」，並針對新住民、兒少、身障者與高齡長者四大不利處境族群，剖析當前制度的盲點與缺口，提出四大幸福行動藍圖。因為「韌性，不是要求弱勢者自己更堅強，而是社會替他們做好的準備。」

國教行動聯盟王瀚陽理事長回應臺南災後心理重建經驗，肯定社會局把民間資源和社工、諮商心理、臨床心理的專業都納入，這些透過賑災基金會的很大的合作和連結。基於過去災後工作經驗呼籲要重視救災者、志工、老師等人的情緒危機，先提供災後支持。以 2016 年前歸仁區的為例，災後我們關心到當地的老師、志工等助人者，在本身也面臨災變巨大生活壓力下，仍然堅守崗位，當時一個 40 個名額的情緒危機處理課程來了 90 人倍增，顯示老師和志工助人者有此心理需求。面對頻繁的颱風風災，基層公務人員在防汛與救災任務中極其辛苦，政府應在服務與出勤之前，全面提供情緒危機

處理的先備知識與心理建設。災後工作使用藝術、文化做社區支持非常重要，因為災後經歷逃難、人口流失，社區的人能夠對自己文化、社區認同（例如歸仁以學校做社區服務基地歷史悠久的『王船祭』等傳統文化活動），當社區居民在共同參與的文化儀式中有認同感、看見希望、感到安心，才會真正願意選擇留在安全的家鄉，齊心協力重建家園。透過災難經驗，讓全臺灣的社區看到災難之前把預防和心理建設做好，加強救災相關人員的心理韌性，未來投入災後重建就會更容易。

世界心理衛生聯盟理事李思賢教授與會回應，本次論壇的呼籲與國際同步響應世界心理健康日。李思賢教授在今天的響應主題「真實的經驗」下，特別以本人就是活的、行動的「生命經驗者」--小兒麻痺病毒患者分享，自小求學的學校教室，都無法自己進教室上樓，師長請同學「揹」我，讓我感覺自己被標籤為「弱勢」；至今已經在台師大任教，還是抱持著學校能夠成為一個無障礙校園，而事實上，想要讓自己健康，想要去使用辦公室旁邊的校內游泳池都是障礙重重。這是真實經驗者的聲音，希望能化為真實的行動。在衛福部和各單位的報告中看到，每個環節都設計的很棒，但每次我這個經驗者，問能不能讓我也能追求更健康、更幸福的心理健康的資源時，答案是沒有人、也沒有錢。連今天能站上台發聲，也是在於現場有沒有無障礙環境。

中華心理衛生協會常務理事、兼心理韌性中心主任丘彥南醫師（資深兒童青少年精神科醫師），代表專業醫學界與非營利組織（NGO），對衛生福利部各司署所提出的「全民心理健康韌性計畫」表達高度肯定與堅定支持。

丘彥南主任長年深耕臨床精神醫學與非營利倡議，他從自身在國立臺灣

大學學生輔導諮商中心擔任顧問、以及在臺大醫院一線診療的實務經驗出發，針對跨部會、跨網絡的實質合作，提出以下極具建設性的精闢觀點與精進建言：

- 倡議「全方位無障礙」與消除日常歧視：

  丘彥南首先呼應李思賢教授對於不利處境族群的關懷。他分享在臺大學輔中心的顧問經驗指出，臺大的身心障礙學生非常積極地在校務會議中提案，這讓大家深刻意識到，「無障礙環境」絕不只是指實體建築的硬體無障礙，更涵蓋了心理與社會環境的無障礙。去汙名化對所有弱勢族群至關重要，例如過往推動思覺失調症的更名（原稱精神分裂症）就是指標案例。中華心理衛生協會近年更積極與民間企業合作、向大眾強力倡議「終止日常歧視」（打擊「歧獸」，因為歧視如同怪獸），透過協助大眾學習如何辨識歧視、理解改善方法，共創一個互信友善、相互尊重的環境，才能從根本增進全民的心理健康與主觀幸福感。

- 推動「以患者為中心」的跨科別整合照護：

  回應國家衛生研究院陳為堅副院長有關社區整合門診的論述，丘彥南舉出臺大醫院早期開設「唐氏症兒整合門診」的成功經驗。該門診實踐了整合性照顧的核心價值，讓兒科、精神科、復健科等各科專家在同一時間、同一個診區共同坐診，脆弱家庭只要來到同一個地方，就能同時獲得不同門診的專業診療，個案管理師與醫療團隊更能現場召開工作研討、即時對接病況。這種「整合性照護」能最大程度減輕脆弱家庭在各科別、各醫院間奔波的照顧負荷，也是未來政策必須擴大落實的方向。

- 強化中央與地方合作及橫向協作，消弭區域資源落差：

丘彥南指出，無論是地方政府在爭取特定精神醫療或兒少保護專用病房，「中央政策與地方實踐」的緊密對接都是關鍵。以「兒少保護示範中心（兒童嚴重受虐性創傷早期介入及整合照護示範中心）」為例，國內雖已成立數家，但並非每個縣市都具備相同量能。由於這涉及地方政府的權責與財源配置，若布建不均，往往會面臨「遠水救不了近火」的實務困境。

- 嚴格檢視特教資源，整合社安網與特殊醫療體系：

  針對矯正司法精神處遇，丘彥南提醒必須嚴謹檢視法務部矯正署轄下矯正學校（如誠正中學等）內特教學生、嚴重情緒行為障礙學生的親師生師資配比。目前的配置雖然帳面上「合乎最低法規」，但在面對具有嚴重情緒困擾的觸法少年時，實務量能顯然「嚴重不足」，亟需由國衛院等智庫進行實證研究，精算出最符合臨床需求的專業人力配置。他呼籲政府應將《兒童及少年福利與權益保障法》、衛福部「兒童青少年嚴重情緒行為障礙精神醫療就醫改善計畫」、社會福利安置機構以及「強化社會安全網」的跨網絡資源實質整合，別讓身心脆弱的孩子在制度的縫隙中被漏接。

- 跨學門融入日常治理：數位、運動、信仰與職場文化：

  最後，丘彥南呼籲政府將心理健康促進全方位融入日常治理。第一，支持國衛院建立國家級的兒少心理發展調查指數，協助教育部、數位發展部等主管機關針對數位工具、網路世界及網路成癮對兒少身心發展的重大衝擊，進行前瞻性的政策指引。第二，心理健康必須融入文化、宗教信仰與運動科學，例如防範不當宗教組織或運動教練對個體身心造成的創傷，並結合國立臺灣師範大學洪聰敏研究講座教授所倡導的「運動與

心理韌性」大腦科學實證，讓規律運動成為基層身心調適的處方。他也在最後向全場發出宏觀呼籲，期許立法院能以身作則，率先為全臺灣的民間與公務體系心理健康示範職場！

【大會總結：全政府全社會動員，2027 延伸教育與勞動政策】

論壇主席**臺灣心理健康聯盟召集人張玨教授**於會後勉勵表示，本次首發網絡論壇凝聚了地方城市與衛福部不同部會的集體智慧，全政府、全社會都在深度回應國際心理健康倡議。她現場隆重預告，**2027 年論壇將持續辦理，並正式將觸角延伸、盤點心理健康融入「教育政策」與「勞動政策」之跨部會體系**。

法規明確納入「心理健康促進」，已為我國心理健康政策揭開全新的一頁。與會之董氏基金會、任林基金會、雙胞胎、女性生涯發展、育幼院失家兒、竹科管理協會、芯福里、ICF、原住民醫學會、照顧者家總等盟友團體今日亦全體合流響應，期待透過中央、地方與民間公私協力的在地行動，強化跨部門無縫銜接，共同編織起最堅實的全民心理健康城市網絡！

媒體聯絡窗口：

臺灣心理健康聯盟召集人張玨 [redacted]

中華心理衛生協會 秘書長溫桂君 [redacted]

臺灣心理健康聯盟 秘書　林侑頡 [redacted]

連絡信箱：tfmh2022@gmail.com